

설사 (Diarrhea) 1차진료 종합 가이드

적용 대상: 1차진료 가정의학과 개원의 | Claude v1.0의 구조와 핵심 내용을 유지하면서 2026년 기준으로 교차검토·수정한 최종 보원판

- v1.1에서 바로잡은 핵심 7가지
- 법정감염병: 2급은 "즉시"가 아니라 24시간 이내 신고. 4급은 표본감시기관이 7일 이내 신고.
 - Racecadotril: 국내 성인 100 mg 캡슐이 허가되어 있으며 급성 설사에 100 mg 1일 3회, 최대 7일 범위에서 사용 가능.
 - KCD: A09.0은 감염성 기원으로 임상 진단한 경우, A09.9는 기원 불명, K52.9는 비감염성으로 명시한 경우. 수액을 뺀다는 이유만으로 E86.0을 붙이지 않는다.
 - C. difficile: 최근 항생제력만으로 선별하지 않는다. 설명되지 않는 새 발병 묶은변 ≥3회/24시간이면 위험인자·완하제 사용을 함께 보고 검사한다.
 - 만성 수양성 설사: 분변 칼프로텍틴/락토파린, Giardia, 셀리악병, 담즙산 설사 평가를 추가하고 현미경적 대장염은 우·좌측 결장 조직검사를 명시한다.
 - 프로바이오틱스: 2020 Cochrane 이후 급성 감염성 설사에서 일률적 routine 처방의 근거는 약하다.
 - 여행자 설사: 2026 CDC 기준은 배변 횟수보다 기능적 중증도 중심. 경증은 항생제 X, 중증/이질은 azithromycin 선호.

1. 교과서적 질환 개요

1.1 정의·기간 분류

구분	실전 정의	1차진료 함의
설사	Bristol 6-7형의 묶은변이 평소보다 증가(흔히 ≥3회/일)	횟수만 묻지 말고 변 굳기, 변실금/급박변 여부까지 확인
급성	<14일	대부분 감염성 또는 식이/약물성. 수분 보충·red flag 선별이 핵심
지속성	14-29일	Giardia/기생충, 감염 후 장기능 변화, 약물, C. difficile 등을 재평가
만성	≥4주	감염성 장염 프레임을 버리고 염증성·흡수장애·약물·기능성 원인으로 전환

1.2 병태생리 4형 - 문진으로 방향을 잡는다

기전	단서	대표 원인
삼투성	금식 시 감소, 식품/약제와 시간 연관	유당불내증, Mg 제제, 술비톨/자일리톨, 락툴로오스
분비성	금식해도 지속, 야간 설사, 대량 수양성	담즙산 설사, 현미경적 대장염, 일부 독소성 감염
염증성	혈변/점액, 발열, 이급후통, 국소 압통	Shigella, Campylobacter, Salmonella, STEC, IBD, 허혈성 대장염
운동성/DGBI	복통·배변 연관, 배변 후 호전, 야간 증상 드물	IBS-D, 갑상선기능항진, 당뇨 자율신경병증, 수술 후

1.3 첫 3분: “기간 → 중증도 → 탈수 → 노출/약물”

- Red flag: 혈변, 지속 고열, 독성 소견/패혈증, 심한 국소 복통·반발통, 중증 탈수, 의식변화, 면역저하, 고령·중증 기저질환.
- 탈수: 기립성 어지럼/저혈압, 빈맥, 경막 건조, 소변 감소, 경구 섭취 가능 여부. 노인·CKD/HF는 수액 전후 재평가 필수.
- 노출: 공동식사/집단발생, 덜 익힌 육류, 생해산물·해수, 여행, 최근 입원·요양시설, 항생제, 유제품.
- 약물: metformin, Mg, acarbose, colchicine, SSRI, PPI, GLP-1 RA, 항생제, 하제. “최근 3개월 신규/증량?”을 고정 질문.

1.4 대변검사는 “3일 넘었다”가 아니라 임상 중증도와 역학으로 결정

검사 적응증	실전
혈변/점액 + 발열, 심한 복통·압통, 패혈증 징후	Salmonella/Shigella/Campylobacter/Yersinia/STEC 등을 포함한 배양 또는 multiplex PCR. STEC 의심 시 Shiga toxin 확인을 우선
집단발생/공동노출, 공중보건상 원인 확인 필요	원인 병원체 범위를 넓히고 보건소와 조기 협의
C. difficile 의심	설명되지 않는 새 발병 묶은변 ≥3회/24h에서 평가. 완하제 사용, 항생제/의료기관 노출, 고령·면역저하 등을 함께 고려. 가 능하면 toxin을 포함한 다단계 알고리즘
지속성/만성	여행 후 ≥2주면 Giardia 등 원충 고려. 만성 수양성은 별도 만성 경로로 전환

2. 치료 - 실제 처방과 항생제 사용 범위

2.1 수분· 전해질이 1차 치료

상황	권장 접근
경증, 경구 가능	ORS 또는 선호하는 수분을 소량씩 자주. 당이 매우 높은 음료를 대량 섭취하면 삼투성 설사를 악화시킬 수 있음. 식사는 굵기지 말고 소량씩 재개
중등도 탈수/반복 구토	LR 또는 NS 500-1,000 mL 후 활력·증상·소변·폐수포 재평가. 고령, 심부전, CKD는 더 작은 용량으로 반복 평가
중증 탈수/AKI/의식 변화	의원에서 수액을 오래 끌지 말고 응급실 전원. 검사와 수액이 전원을 지연시키면 안 됨

2.2 대증약 - “쓸 수 있음”과 “핵심 치료”를 구분

약제	성인 실전 사용	주의
Loperamide	초회 4 mg, 이후 묽은변마다 2 mg; 최대 16 mg/일, 보통 1-2일 단기	혈변 또는 발열 동반 설사에서는 단독 사용 금지. 독성거대결장/중증 대장염 가능성, 치료 전 CDI 의심 시 피함
Racecadotril 100 mg	국내 허가: 100 mg 1일 3회, 식전 권장. 정상변 2회까지, 최대 7일	ORS 대체가 아니라 보조 증상치료. 간·신장에 주의. 2025 허가사항에 중증 피부반응 경고 반영
Diosmectite	선택적 증상 완화. 다른 경구약과 시간 간격을 둬	성인 근거는 일관되지 않아 필수약으로 보지 않음. 변비/약 흡수 방해 설명
Probiotics	급성 감염성 설사 routine 처방은 권하지 않음	2020 Cochrane: 48시간 이상 지속 여부에 거의 차이 없고 기간 단축은 불확실. 면역저하/중심정맥관 환자 특히 신중

2.3 경험적 항생제 - 대부분의 수양성 설사에는 사용하지 않는다

국내 2019 지침을 유지하되, STEC와 여행자 설사 최신 기준을 덧붙인다

- 고려: 혈변/점액변 + 발열 또는 전형적 이질증상(빈번한 소량 혈성변, 경련성 통증, 이급후중), 고열/패혈증을 동반한 여행자 설사, 면역저하자의 혈성 설사.
- STEC 의심: 혈성 설사인데 발열이 없거나 낮고 덜 익힌 육류/집단노출이 있으면 Shiga toxin 검사를 우선하고 항생제는 회피. 항생제가 HUS 위험을 높일 수 있음.
- 비장티푸스성 Salmonella: 건강한 성인의 단순 장염은 보통 항생제 불필요. 고위험 숙주/침습성 감염은 별도 판단.
- 경험적 선택: 국내 및 동남아의 Campylobacter FQ 내성을 감안하면 azithromycin이 유리한 상황이 많다. 배양/PCR을 시행했다면 결과에 따라 표적치료로 조정.

여행자 설사(2026 CDC): 기능적 중증도로 결정

중증도	항생제	대증
경증: 활동에 지장 없음	권장하지 않음	수분, 필요 시 loperamide
중등도: 불편하고 활동 방해	사용 가능	loperamide 단독 또는 병용 가능(혈변/발열 제외)
중증: 활동 불가; 모든 이질 포함	권장. azithromycin 선호	loperamide는 보조로만; 혈변/발열이면 단독 금지

예: azithromycin 1 g 1회(오심에 부담되면 같은 날 분할) 또는 500 mg 1일 1회 3일. 동남아/이질/발열성 설사에서 선호. Rifaximin은 비침습성 설사에만.

2.4 C. difficile - v1.0의 가장 중요한 최신화

진단/중증도	1차진료 적용
검사	새로 발생한 설명되지 않는 묽은변 ≥3회/24h. 무증상 보균 검사·치료, 동일 episode의 7일 이내 반복검사, test-of-cure는 피함
치료 업데이트	2021 IDSA/SHEA: 초기 CDI에서 fidaxomicin 선호, 경구 vancomycin은 허용 가능한 대안. metronidazole은 더 이상 일반적 1차 선택이 아님
Refer	저혈압/쇼크, ileus/megacolon, AKI, WBC 현저 상승, 고령·면역저하·재발은 응급실/감염내과·소화기내과. 안정적 비중증 확진은 원내 추적 역량이 있으면 직접 관리 가능하나 낮은 문턱으로 전문과 상의

2.5 KCD-9 상병코드 - “처방에 맞추는 코드”가 아니라 임상기록에 맞춘다

코드	상병명/사용 원칙
A09.0	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염 - 임상적으로 “감염성 위장염”이라고 판단·기록한 경우
A09.9	상세불명 기원의 위장염 및 결장염 - 감염성/비감염성 기원을 정하지 못한 경우
K52.9	상세불명의 비감염성 위장염 및 결장염 - 비감염성이라고 명시한 경우
K58.0 / K59.1	설사형 IBS / 기능성 설사 - 만성·재발성, 경도증상 배제 후
E73.9	상세불명의 유당불내증 - 식이 연관이 명확할 때
E86.0	탈수 - 탈수가 임상 진단으로 기록되어 있을 때. “IV 수액 시행”만으로 자동 병기하지 않음

※ KCD-9는 2026.1.1 시행. 원내 EMR 상병 마스터와 심사기준은 최신 상태를 확인한다.

3. 만성·지속성 설사: 놓치기 쉬운 질환과 최신 감별

3.1 문진 3종 세트는 유지하되 한 가지를 추가

고정 질문 4개

- 유제품: “우유·아이스크림 등을 먹고 30분~수시간 안에 복부팽만/설사가 반복되나요?” 필요하다면 1-2주 유당 제한 후 재노출로 확인.
- 신규/중량 약: metformin, Mg, acarbose, colchicine, SSRI, PPI, GLP-1 RA, 항생제, 하제. 중단 가능 약은 위험·편익을 보고 조정.
- 현미경적 대장염: 특히 중년·고령의 비혈성 수양성/야간 설사. 내시경 육안이 정상이어도 배제되지 않음. PPI/NSAID/SSRI 연관은 관찰 연구 기반이므로 “원인약 확정”보다는 약물 재검토.
- 담낭절제/회장질환: 식후 급박변, 담낭절제 후 수양성 설사, 회장절제/크론병 병력이면 담즙산 설사를 생각.

3.2 4주 이상 수양성 설사: 최소 평가 묶음

평가	실전 포인트
기본	CBC, 전해질/Cr, 간기능, albumin, 필요 시 ferritin/iron, TSH. 체중 변화와 영양상태 확인
IBD 선별	분변 calprotectin(또는 lactoferrin)이 접근 가능하면 우선 활용. CRP는 보조이며 정상이라고 IBD를 완전히 배제하지 않음
Giardia	만성 수양성 설사에서 적극 검사. 여행력 없다고 Giardia를 완전히 배제하지 않음
셀리악병	서구 지침은 IBS-D/만성 수양성 설사에서 tTG-IgA + total IgA를 권고. 한국은 유병률이 낮아도 철결핍, 체중감소, 가족력/자가면역질환, 불응성 증상이면 낮은 문턱으로 시행
담즙산 설사	검사 접근성이 제한되므로 병력과 specialist 협의 하에 담즙산 결합제 치료반응을 활용할 수 있음
내시경	혈변, 빈혈/저알부민, 체중감소, 야간 증상, 고령에서 새로 발생, CRC screening 미완료 등은 대장내시경. 현미경적 대장염 의심 시 우측+좌측 결장 조직검사를 의뢰서에 명시

3.3 만성 설사 압축 감별표

단서	우선 의심	다음 단계
유제품 후 팽만·가스	유당불내증	유당 제한 후 재평가/재노출
최근 신규약/중량	약물유발	가능하면 중단·감량 후 1-2주 재평가
복통·배변 연관, 야간X, alarm X	IBS-D	positive diagnosis 전략. 필요 시 calprotectin/CRP, 셀리악 선별 후 관리
복통 없이 만성 묽은변	기능성 설사	alarm 배제 후 식이·증상치료
야간/대량 수양성, 내시경 정상	현미경적 대장염	우·좌측 결장 조직검사. 진단 시 budesonide가 specialist 1차 치료
담낭절제 후 식후 급박변	담즙산 설사	소화기내과와 검사/담즙산결합제 trial 상의
혈변/체중감소/빈혈/저albumin	IBD/암/허혈 등	지체 없이 내시경 및 기질적 원인 평가
발열 없는 혈성 설사 + 육류/집단노출	STEC	Shiga toxin 포함 검사, 경험적 항생제 회피

3.4 2020년 이후 최신 지견 - 기존 자료에 더할 내용

주제	업데이트	1차진료 적용
Multiplex PCR	원인균 검출률이 높지만 DNA 검출=원인 확정은 아님	양성 결과를 증상/역학과 맞춰 해석. 모든 양성에 항생제 처방 금지
PI-IBS	2024 meta-analysis: 급성 위장관염 후 PI-IBS 약 14.5%, odds 약 4배 증가	급성 감염 후 수개월 증상이 남을 수 있음을 설명하되 alarm을 재확인하고 바로 “만성 장염”으로 오진하지 않음
현미경적 대장염	2021 유럽 지침: 최소 우측+좌측 결장 biopsy, 육안 정상이어도 조직진단	의뢰서에 “microscopic colitis r/o, right & left colon biopsy”를 구체적으로 기재
급성 probiotics	2020 Cochrane에서 고품질 연구 중심으로 효과가 불확실/미미	환자 비용을 고려해 routine package 처방에서 제외 가능
CDI	fidaxomicin 우선으로 이동, vancomycin 대안	원래 검사/약 접근성 없으면 의심 단계에서 조기 의뢰

4. 외래 실전 Flow + FM 직접관리/Refer 경계

4.1 급성 설사 3분 요약리츠

- [1] 기간 <14일 / 14-29일 / ≥4주 → ≥4주는 만성 경로
- [2] Red flag? 혈변, 지속 고열, 독성/패혈증, 반발통·국소 심한 압통, 중증 탈수, 면역저하 → YES면 검사 + 의뢰/전원 판단
- [3] 탈수? 경구 가능하면 ORS 중심 / 중등도면 IV 후 재평가 / 중증이면 응급실
- [4] 원인 문진 공통식사·여행·해산물/육류 + 유제품 + 신규약 + 항생제/입원 + 담낭절제
- [5] 검사? 염증성/패혈증/집단발생/공중보건 필요 시 stool test, CDI는 ≥3 unformed stool/24h + 설명 안 되는 새 발병일 때
- [6] 처방 ORS ± 단기 대증약. 경형적 항생제는 좁은 적응증만
- [7] 안전망 혈변, 고열, 소변 감소, 심한 어지럼, 복통 악화 → 즉시 재평가. 고위험/검사 시행 환자는 48-72h 또는 결과 설명 재진

4.2 가정의학과 직접 관리 vs 의뢰

구분	FM 직접 관리	의뢰/전원
급성	경증-중등도 수양성 설사, 경구/단기 IV로 교정되는 탈수, 혈변·독성소견 없음	중증 탈수, 패혈증, 복막 자극, 심한 국소통증, AKI/전해질 이상, 고위험 면역저하
감염	대부분의 자가한정성 장염, 여행자 설사 교육/선택적 자가치료	enteric fever, 이질/콜레라/EHEC 등 신고대상 의심·확인, 반복/복잡 감염
CDI	원래 진단·약·일차 추적 가능한 안정적 비중증 확인	중증/fulminant, 재발, 진단 불명확, 고위험 숙주, 원내 치료여건 부족
만성	유당/약물/기능성 가능성이 높고 alarm 없는 환자의 초기 평가·생활/약 조정	혈변, 체중감소, 빈혈/저albumin, 야간 설사, 고령 새 증상, 지속 despite initial workup, 현미경적 대장염 의심

4.3 법정감염병·집단발생 - 2026 기준으로 수정

신고 타이밍

- 제2급: 콜레라, 장티푸스, 파라티푸스, 세균성이질, 장출혈성대장균감염증, A형간염 등은 환자/의사환자/병원체보유자 범위에 따라 24시간 이내 신고.
- 제4급 장관감염증: 노로바이러스, 살모넬라, 캄필로박터 등은 표본감시 체계. 지정 표본감시기관은 7일 이내 보고.
- 집단발생: 같은 음식/장소 노출 후 여러 명이 유사 증상이면 결과가 나오기 전이라도 관할 보건소와 조기 상의. 검사 의뢰 환자는 결과 회신·신고 여부를 추적하는 원내 리스트를 둔다.

5. 개원 경영 - 과잉진료 없이 재진과 진료 완결성을 높이는 방법

5.1 임상적으로 정당한 수익 구조

항목	임상 근거/운영 포인트	차트
수액	경구 섭취 곤란, 반복 구토, 기립성 증상, 소변 감소 등 실제 탈수 위험. "피곤해서 수액"과 구분	IV 전후 활력·경구섭취·소변·탈수 소견. E86.0은 탈수 진단이 있을 때만
검사	중증도/역학에 맞춘 대변검사, 만성 설사에서 선택적 혈액·분변검사	왜 검사했는지 적응증을 문장으로 남김
결과 재진	stool PCR/culture, 혈액검사 등 actionable result가 있으면 설명 일정을 처음부터 설정	전화/비대면 가능 범위는 원내 규정 준수. 경고소견이면 대면 재평가
내시경 연계	만성 설사 + alarm, 연령/CRC screening 필요, microscopic colitis 의심에서만	급성 장염 회복 직후 routine 내시경을 매출 목적으로 권하지 않음
여행 전 상담	ORS, 항지사제 사용 기준, 중증도별 자가 항생제, A형간염/장티푸스 백신	여행자·기간·면역상태·상담 내용을 기록

5.2 재진 설계 4단계

- 1) 안전망: 경증이면 “호전 없거나 red flag 발생 시 재내원”으로 충분. 모든 환자에게 기계적 2일 재진을 잡지 않는다.
- 2) 고위험군: 고령, 중등도 탈수, 기저질환, 검사 시행 환자는 24-72시간 내 추적을 구체화.
- 3) 지속성 전환: 2주 이상이면 Giardia/여행/약물/CDI를 재평가, 4주 이상이면 만성 pathway로 전환.
- 4) 동반질환 통합: metformin/GLP-1, 갑상선, 담낭절제, 당뇨 자율신경병증 등 원인을 같은 방문에서 정리해 장기 관리로 연결.

5.3 개원가에서 흔한 패턴 - 체득할 것/버릴 것

체득: 탈수 평가를 먼저 하고, 짧은 안전망 문구를 표준화하며, 검사 결과를 추적하는 시스템을 둔다. 버릴 것: 경증 장염에 광범위 항생제·3세대 세팔로스포린 관행 처방, 상병 코드를 처방 정당화용으로 고르는 습관, 만성 설사를 “예민한 장”으로 끝내는 습관.

6. EMR 복사용 템플릿 + 환자설명 + 셀프체크

6.1 급성 설사 SOAP 템플리

CC Diarrhea onset () , frequency (/day), Bristol ()
Blood/mucus (- / +) Fever (- / + , Tmax) Vomiting (- / +) Abd pain (- / + , site)
Nocturnal diarrhea (- / +) Weight loss (- / +) Tenesmus (- / +)
Exposure 공중식사() 여행() 생해산물() 달ikh된 육류() 유제품() sick contact()
Drug 신규/중량약 3개월() 항생제/입원·요양시설() 완하제 48h() Metformin/PPI/Mg/GLP-1()
PE BP () PR () BT () orthostatic symptom () mucosa dry() urine last ()h ago
Abd soft/rigid, tenderness (), rebound (), bowel sound ()
A # Acute gastroenteritis/diarrhea - origin unspecified A09.9 OR infectious origin documented A09.0
Dehydration E86.0 only if clinically diagnosed # r/o lactose intolerance E73.9
Red flags: none / ()
P 1) ORS/수분 보충, 식사 소량 재개 2) 대증약 적응증/금기 설명
3) Empiric antibiotics: not indicated / indicated because () 4) Stool test because ()
5) Safety net: 혈변, 지속 고열, 소변감소, 심한 어지럼/복통 악화 시 즉시 재평가
6) F/U: PRN / 24-72h / result review on () 7) ≥2주 지속 시 persistent pathway, ≥4주 시 chronic pathway

6.2 환자 설명 스크립트

- 항생제를 왜 안 쓰냐: “급성 설사는 대부분 며칠 안에 좋아지고, 항생제가 필요한 경우는 일부입니다. 지금은 탈수를 막는 게 가장 중요합니다.”
- 수분: “한 번에 많이 마시지 말고 조금씩 자주 드세요. 설사가 많다면 ORS가 가장 균형이 좋고, 너무 단 음료를 많이 마시면 오히려 설사가 늘 수 있습니다.”
- 지사제: “피가 섞이거나 열이 나는 설사는 지사제를 혼자 드시면 안 됩니다.”
- 재내원: “피가 섞인 변, 계속되는 고열, 소변이 현저히 줄거나 일어설 때 쓰러질 듯한 어지럼, 복통이 점점 심해지면 바로 다시 평가받으세요.”
- 만성: “한 달 이상이면 단순 장염과는 접근이 달라집니다. 내시경이 정상처럼 보여도 조직검사로만 진단되는 질환이 있습니다.”

6.3 여행자 설사 상담 카드

항목	환자 안내
예방	손위생, 안전한 물/음식. 식품 주의만으로 위험을 0으로 만들 수는 없음. 일반 여행자에게 예방적 항생제는 권하지 않음
준비물	ORS, loperamide, 고위험 목적지/상황이면 중증도 기준과 함께 standby azithromycin 처방을 고려
자가치료	경증은 수분·증상치료. 중증도는 항생제 선택 가능. 활동 불가/이질/발열성은 azithromycin 선호. 혈변/발열이면 loperamide 단독 금지
귀국 후	>14일 지속 시 Giardia/원충 포함 평가. 발열·전신증상이 동반되면 여행지에 따라 malaria/enteric fever 등 감염내과 상의

6.4 셀프 체크 8문항

#	질문	정답 핵심
1	급성 설사의 1차 치료?	수분·전해질 보충
2	STEC 의심 시 항생제?	회피하고 Shiga toxin 검사 우선
3	Loperamide 단독 피할 상황?	혈변 또는 발열, 중증 대장염/독성거대결장 가능성
4	CDI 검사 대상?	설명되지 않는 새 발병 뉘은번 ≥3회/24h; 완하제 등 대체원인 확인
5	초기 CDI 치료 최신 흐름?	fidaxomicin 선호, oral vancomycin 대안; metronidazole routine 1차 아님
6	내시경 정상인 만성 수양성 설사?	현미경적 대장염; 우·좌측 결장 biopsy
7	2급 장관감염병 신고 시점?	24시간 이내
8	여행자 설사 경증에 항생제?	권장하지 않음

주요 참고문헌 / 업데이트 근거

- 질병관리청·대한감염학회·대한항균요법학회. 급성 위장관계 감염 항생제 사용지침. Infect Chemother. 2019;51:217-243. (2026 KDCA 항생제 지침 목록에서 급성 위장관 감염 최신 배포판으로 확인)
- Shane AL, et al. IDSA Clinical Practice Guidelines for Infectious Diarrhea. Clin Infect Dis. 2017;65:e45-e80.
- Johnson S, et al. SHEA/IDSA 2021 Focused Update for Clostridioides difficile Infection in Adults. Clin Infect Dis. 2021.
- Lacy BE, et al. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021;116:17-44.
- Miehke S, et al. European guidelines on microscopic colitis. United European Gastroenterol J. 2021;9:13-37.
- Collinson S, et al. Probiotics for treating acute infectious diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2020;CD003048.
- CDC Yellow Book 2026. Travelers' Diarrhea / Post-Travel Diarrhea.
- Porcari S, et al. Prevalence of IBS and functional dyspepsia after acute gastroenteritis: systematic review and meta-analysis. Gut. 2024;73:1431-1440.
- AGA. Laboratory evaluation of functional diarrhea and IBS-D in adults. Gastroenterology. 2019.
- 질병관리청 감염병포털. 법정감염병 신고시기: 1급 즉시, 2·3급 24시간 이내, 4급 7일 이내 (2026.09.01 확인).
- 통계청. 제9차 한국표준질병·사인분류(KCD-9), 2026.1.1 시행; 질병관리청 진단·수술 코드 분류지침(위장염/탈수 코딩 원칙).

주의: 본 자료는 교육용 1차진료 학습자료입니다. 실제 처방·급여·신고·검사 가용성은 환자 상태, 최신 식약처 허가사항, KDCA/HIRA 고시 및 지역 검사실 기준을 우선합니다.